

ФИО студента, группа _____

Практическая работа_ Первая помощь при клинической смерти

(Нормативные акты в области оказания ПП. ПП при клинической смерти)

Цель работы: изучить и освоить первую помощь при клинической смерти: технику компрессий грудной клетки (КГК) и искусственной вентиляции легких.

Оборудование: учебные таблицы, аптечка первой помощи, робот-тренажер «Гоша», медицинские средства защиты, кровоостанавливающие жгуты, учебно-методические материалы.

Ход работы

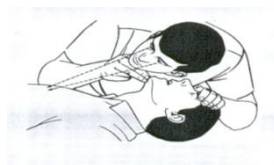
1. Выучить к занятию состояния, при которых оказывается ПП и мероприятия по оказанию ПП (Приказ Минздравоохранения РФ № 220н, приложение 1 и 2); понятия клинической и биологической смерти; понятие первой помощи (ФЗ №323, ст. 31).

2. Первая помощь при клинической смерти.

2.1. Мероприятия по определению признаков жизни у пострадавшего:

А) Определение наличия сознания

Б) Определение наличия дыхания



2.2. Освойте технику компрессий грудной клетки (КГК) и искусственной вентиляции легких, используя фантомы для проведения непрямого массажа сердца и ИВЛ. Заполните пропуски в тексте.

Сердечно-легочная реанимация (СЛР) проводится при отсутствии признаков жизни (клинической смерти). Она заключается в проведении **компрессий грудной клетки** и **искусственного дыхания**.

Техника компрессий грудной клетки



Рис. 1. Техника непрямого массажа сердца

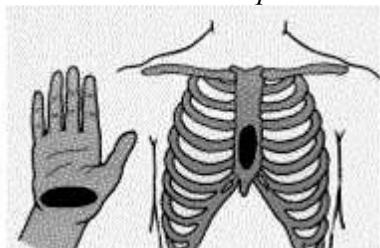


Рис. 2. Место

соприкосновения руки и грудины при непрямом массаже сердца

Пострадавшего кладут на твердую поверхность, на спину. Шею, грудную клетку и живот освобождают от одежды; поясной ремень расстегивают и ослабляют, бюстгальтер смещают вверх.

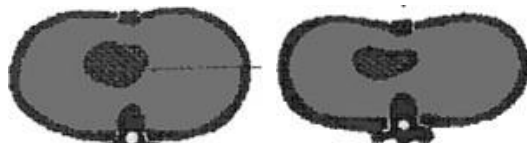


Рис. 3. Поперечный разрез грудной клетки
а) при декомпрессии б) при компрессии

Оказывающий помощь человек встает сбоку (на колени). Основания ладоней обеих рук (рука на руку) помещает на середину грудины (выше мечевидного отростка на 2-3 см), пальцы рук сцепляет в замок (рис.1,2). Затем производит надавливание на грудину выпрямленными в локтевых суставах руками с силой, чтобы грудина сместилась к позвоночнику на ____ см (для взрослых, рис.1, 3). Надавливание производить, используя как силу рук, так и тяжесть плечевого пояса, наклоняя туловище. После каждого толчкообразного надавливания быстро расслабить руки, не отрывая их от грудины. Следующее надавливание выполнять только после декомпрессии. **Частота надавливаний** _____ раз в мин (**пострадавшим пожилого возраста** количество компрессий необходимо ограничить до **70–80**). **Детям старше года** надавливание на грудину проводят ладонью одной руки на глубину равную 1/3 высоты грудной клетки, **грудным детям** – двумя пальцами на глубину равную 1/3 высоты грудной клетки. Частота надавливаний такая же, как у взрослых.

Начинают СЛР с _____ надавливаний на грудину (за 20 сек), далее после восстановления проходимости верхних дыхательных путей проводят _____ вдувания (см. ниже), следя за движением грудной клетки на выдохе, затем вновь 30 надавливаний – 2 вдувания, и так продолжая чередовать их, до появления признаков жизни или передачи пострадавшего прибывшим медработникам. **При выполнении реанимационных мероприятий двумя спасателями:** один выполняет 30 надавливаний на грудину (КГК), далее второй – 2 вдувания (ИВЛ). На выполнение 2 вдуваний можно потратить не более 5 сек. Каждые две минуты спасатели меняются местами.

При отсутствии защитных средств для проведения ИВЛ и навыков проведения ИВЛ возможно проведение только качественных компрессий грудной клетки с частотой **100–120 в мин без проведения искусственных вдохов**. Однако, полноценная СЛР предпочтительнее. При остановке кровообращения вследствие гипоксии (утопление, непроходимость дыхательных путей инородным телом, отравления), а также у детей СЛР без искусственного дыхания будет не эффективной.

ИВЛ заключается во вдувании воздуха в легкие пострадавшего для обеспечения его организма кислородом.

Для эффективной ИВЛ необходимо выполнить следующие условия (перечислите):

— _____

(запрокидывают голову пострадавшего (одной рукой надавливают на лоб, другой приподнимают подбородок) (рис. 4, 5);

— _____;

— _____;



а

б

Рис. 4. Дыхательные пути на срезе головы:

а) закрытые дыхательные пути – до запрокидывания головы;

б) открытые дыхательные пути – после запрокидывания головы

При необходимости ротовую полость очищают от слизи, рвотных масс, инородных тел пальцем, обернутым в марлевую салфетку, носовой платок.



а

б

Рис. 5. Искусственное дыхание методом «изо рта в рот»:

а) вдувание воздуха, б) пассивный выдох

Для защиты от передачи инфекций необходимо вставить между губами пострадавшего устройство для ИВЛ из аптечки (использовать карманную маску для ИВЛ). После восстановления проходимости дыхательных путей (рис. 5) и зажав большим и указательным пальцами нос, оказывающий помощь делает вдох, плотно прижимает свои губы ко рту пострадавшего и равномерно выдыхает (для пострадавшего это будет вдох) в течение одной секунды, что должно соответствовать дыхательному объему 500–600 мл. После вдоха рот пострадавшего освобождают для пассивного выдоха, наблюдая за тем, как грудная клетка опускается. Голова должна оставаться в том же положении, что и при вдохе (дыхательные пути должны оставаться открытыми).

ИВЛ детям первого-второго года жизни проводят способом «рот в рот и нос».